המועצה המדעית
SCIENTIFIC COUNCIL
ההסתדרות הרפואית בישראל
Israeli Medical Association
חיזוק רפואי זז
ההתמחות שלנו

המועצה המדעית ועדת הבחינות

בחינות שלב א'

רפואה פנימית

13.06.2024

מס' השאלות : 100

1. בת 46 פונה למיון בשל תחושת דופק מהיר. בבדיקתה: סינוס טכיקרדיה 130 לדקה ורעד עדין בידיים. במעבדה: ערכי TSH מתחת לסף הגילוי ו-fT4 פי 4 מהנורמה. במיפוי בלוטת התריס קליטה דיפוזית. איזה מבין המצבים הבאים עשוי להסביר את הקליניקה והממצאים בסבירות גבוהה?

   א. המטופלת עברה צנתור כלילי לפני 3 חודשים
   ב. המטופלת מדווחת על כאבי גרון, רגישות וחום סיסטמי ויש לה שקיעת דם של 100 מ״מ לשעה
   ג. המטופלת סובלת מהפרעת אכילה ומסתבר שנטלה אלטרוקסין של אחותה לצורך ירידה במשקל
   ד. למטופלת יש איחור במחזור ולאחרונה עברה בירור גניקולוגי והועלה חשד לtrophoblastic disease

2. בן 58, לפני 8 חודשים עבר השתלת כליה מן החי על רקע ADPKD. מטופל ב-tacrolimus, mycophenolate mofetil ו-prednisone. בחודשיים האחרונים הוא עייף, נוטה לשכחה אך ממשיך להיות פעיל ולנהל את משרדו. לפני שבועיים סבל מתפרחת שנחשדה כצלוליטיס אך לא הגיבה לטיפול אמפירי. מזה שבוע חום סביב 38 מעלות צלזיוס ללא תלונות חדשות. איזה מבין המחוללים הבאים הוא המחולל הסביר ביותר הגורם למחלתו?

   א. BK virus
   ב. CMV
   ג. HSV
   ד. Cryptococcus

3. בן 78 מאושפז בשל זיהום בדרכי השתן (UTI) וסובל מדלירים. מה ההשלכות של הדלירים?

א. לדלירים אין השלכות קצרות או ארוכות טווח
ב. אחוז התמותה מדלירים באשפוז דומה לאחוז התמותה מספסיס
ג. דלירים משפיע על התמותה בטווח הארוך אך לא בטווח הקצר
ד. טיפול פרמקולוגי בדלירים מהווה גורם סיכון להתפתחות דמנציה

4. בת 40, בשנה האחרונה סובלת מתופעת ריינו, ארתרלגיה ועיבוי עור דיפוזי. בבירור נמצא: ANA חיובי בכייל 1:160 ו- Anti RNA Polymerase III חיובי. פונה למלר"ד בשל כאב ראש פרונטלי חדש בעוצמה 8/10. בבדיקה: ל"ד 155/100. במעבדה: המוגלובין 10 g/dl (בסיס 11.5) נורמוציטי, טסיות 100,000/µl, במשטח דם שברי תאים 4-6 בשדה. קריאטינין 1.2 mg/dl (בסיס 0.6), INR – תקין. בסטיק שתן - המטוריה מיקרוסרופית. בירור בשאלת TTP שלילי. כיצד יש לטפל בחולה?

א. Pulse IV methylprednisolone בשילוב עם captopril
ב. captopril במינון עולה עד לאיזון לחץ הדם
ג. Plasmapheresis בשילוב עם captopril
ד. נוזלים לוריד עד נרמול הקריאטינין ואז captopril

5. בת 53, ללא מחלות רקע. מזה כשנה וחצי מתלוננת על דיספגיה למוצקים ולנוזלים וירידה במשקל של כ-5 ק"ג. בגסטרוסקופיה נמצא ושט מורחב, ללא היצרות או חסימה. במנומטריה נמצאה ירידה ברלקסציה של ה- lower esophageal sphincter (LES) ובפריסטלטיקה של הושט. מה נכון לגבי אפשרויות הטיפול?

א. הזרקת טוקסין בוטולניום ל-LES יעילה רק בשליש מהמקרים
ב. להרחבה פנאומטית אנדוסקופית שיעור פרפורציות גבוה מ- 15%
ג. ל- peroral esophageal myotomy שכיחות נמוכה של רפלוקס לאחר הפעולה
ד. לניתוח ע"ש Heller יעילות גבוהה מ- 80% בהקלת התסמינים

6. בן 34, בריא בדרך כלל, מתלונן על שיעול וחום בשבוע האחרון. בבדיקתו: חום $38.3^{0}C$, 14 נשימות בדקה, לחץ דם 135/75 ממ"כ, דופק 85 בדקה, בהאזנה לבסיס הימני כניסת אוויר והדיות ירודים, פרמיטוס מוגבר וחרחורים אינספירטורים. צילום החזה **בתמונה 1**. מבין הבאים מה הטיפול המומלץ?

   א. Doxycycline
   ב. Levofloxacin
   ג. Trimethoprim-sulfamethoxazole
   ד. Amoxicillin-clavulanate

7. איזה מבין המשפטים הבאים נכון לגבי סטטינים ו-DILI (drug induced liver injury)?

   א. כ-10% מהחולים המטופלים בסטטינים יפתחו הפרעה משמעותית באנזימי כבד
   ב. chronic hepatitis C <u>לא</u> מהווה גורם סיכון לפתח DILI כתוצאה מטיפול בסטטינים
   ג. התחלת טיפול בסטטינים מחייבת מעקב אחר תפקודי כבד ב-6 חודשים ראשונים לטיפול
   ד. rosuvastatin גורם לעליה באנזימי כבד בשכיחות גבוהה יותר מאשר simvastatin

8. איזה מבין הפתוגנים הבאים קשור בשכיחות גבוהה יותר להתפתחות זיהומים אנדווסקולרים?

   א. *Salmonella typhi*
   ב. Nontyphoidal *Salmonella*
   ג. *Salmonella paratyphi*
   ד. *Shigella dysenteriae*

9. בת 61, ללא מחלות רקע או טיפול תרופתי, מאושפזת עקב קושי בנשימה מזה מספר חודשים והיפוקסמיה חדשה. צילום חזה מצורף **(תמונה 2)**. בבדיקת תפקודי ריאות נצפתה הפרעה רסטרקטיבית קשה עם דיפוזיה תקינה. בגזים עורקיים התקבלה התוצאה הבאה:

pH 7.31, PCO_2 70mmHg, HCO_3 37meq/l, PO_2 50mmHg

איזו מבין האבחנות הבאות תסביר בסבירות גבוהה את מצבה?

א. Amyotrophic lateral sclerosis
ב. Idiopathic pulmonary fibrosis
ג. Severe COPD
ד. Left diaphragmatic paralysis

10. בן 32, גולש גלים, מובא לחדר המיון במצב ישנוני לאחר שחזר מהרפובליקה הדומיניקנית. בבדיקתו, ישנוני - סטופורוטי, לחץ דם 100/60 ממ"כ, דופק 125 סדיר, חום 39.8^0C, 26 נשימות שטחיות בדקה, סימני דמם בריריות הפה. כבד וטחול נימושים בקצותיהם. במעבדה - המוגלובין 10.4 גר'/ד"ל, לויקוציטים 14,000 בממ"ק, טסיות 35,000 בממ"ק, קריאטינין 3.4 מ"ג/ד"ל, בילירובין 4.5 מ"ג/ד"ל. מה יכלול טיפול הבחירה?

א. High dose corticosteroids
ב. Caplacizumab
ג. Artesunate
ד. Infliximab

11. בת 80, מופנית לאשפוז בעקבות בדיקות דם בקהילה שהדגימו אי ספיקת כליות חדה (AKI) עם עליית קריאטינין לערך של 2 מ״ג/ד״ל (מבסיס 0.8 מ״ג/ד״ל). ה- AKI התפתח כשבוע לאחר שהייתה מאושפזת עקב זיהום בדרכי השתן וטופלה ב- gentamicin למשך 7 ימים. איזה מבין הבאים נכון לגבי פגיעה כלייתית מאמינוגליקוזידים?

א. לרוב הפגיעה מלווה בהיפרמגנזמיה
ב. שמירה על רמות תרופה תקינות לא מונעת התפתחות AKI
ג. ברוב המקרים, ATN משני לאמינוגליקוזידים מופיע ב- 72 השעות הראשונות
ד. לרוב מתאפיינת באוליגוריה

12. הצלקת הניתוחית של מטופל שעבר השתלת לב מתקשה להחלים. איזה מבין התכשירים הבאים עלול להיות קשור למצב זה ?

א. Tacrolimus
ב. Sirolimus
ג. Azathioprine
ד. Mycophenolate mofetil

13. בן 60, ברקע יתר לחץ דם והשמנת יתר. מגיע למרפאה עקב תלונות על דפיקות לב. תרשים האק״ג **בתמונה 3.** איזה מבין הצעדים הבאים עשוי להוריד היארעות של אירועים חוזרים?

א. איזון לחץ הדם
ב. טיפול ב- calcium channel blockers
ג. טיפול ב-acetylsalicylic acid
ד. הפחתת צריכת קפאין למינימום

14. בת 30 אובחנה עם לופוס נפריטיס class 3. מטופלת ב- mycophenolate mofetil (MMF) ו hydroxychloroquine. מחלתה יציבה כבר שנה ללא פרוטאינוריה וללא המטוריה, קריאטינין 0.5 מ״ג/ד״ל ושאר ביטויי הזאבת שקטים. החולה מעוניינת להרות. מה ההמלצה לגבי המשך הטיפול?

א. המשך hydroxychloroquine ו MMF ללא שינוי
ב. הפסקת hydroxychloroquine והמשך MMF ללא שינוי
ג. הפסקת hydroxychloroquine והחלפת MMF ב- azathioprine
ד. המשך hydroxychloroquine והחלפת MMF ב- azathioprine

15. בן 45, פונה להערכה בשל אי סבילות למאמץ. בבדיקתו הגופנית אוושה סיסטולית, ובאקו לב ממצאים המתאימים ל-hypertrophic obstructive cardiomyopathy. מה נכון לגבי ממצאי ההאזנה במצב זה?

א. האוושה תשמע מקסימאלית במרווח בין צלעי שני מימין
ב. האוושה תתגבר בעת הרמת רגלי המטופל
ג. האוושה תהיה מיד-סיסטולית
ד. תשמע אוושה דיאסטולית אפיקלית נלווית (Austin Flint murmur)

16. למי מהמטופלים הבאים עם אי ספיקת כליות סופנית התווית נגד מוחלטת להשתלת כליה?

א. נשא HIV עם undetected viral load
ב. נשא HCV שעדיין לא קיבל טיפול אנטיויראלי
ג. בעל סוג דם B שיש לו תורם חי עם סוג דם A
ד. בת 66 שהחלימה מסרטן שד לפני שנה

17. בת 75, הוצאה מביתה ע״י שירותי הרווחה לאחר שנמצאה מוזנחת ומתלוננת על חולשה. במעבדה: Hb – 8g/dl, MCV - 120fl. מצורף משטח דם פריפרי **(תמונה 4).** מה צפוי להימצא בבדיקתה הגופנית?

א. לשון גדולה וכאובה
ב. טחול מוגדל
ג. לימפאדנופטיה היקפית
ד. כבד מוגדל

18. בן 70, ברקע ידוע על סוכרת, אי ספיקת לב וממאירות ריאה גרורתית מסוג small cell carcinoma. מתאשפז עקב השתנה מרובה. באיסוף שתן 3.5 ליטר לילה, אוסמולריות שתן - 200 מאוסמול/ק״ג. מה הסיבה <u>הסבירה ביותר</u> לממצאים אלו?

א. Resolving ATN
ב. Uncontrolled diabetes
ג. Hypercalcemia
ד. High dose furosemide

19. בת 30 מתאשפזת בשל זיהום בדרכי השתן ומדווחת על אמנוריאה בחודשיים האחרונים כשעד לפני 4 חודשים היו וסתות סדירות לחלוטין. בדיקת הריון שלילית ופרולקטין מוגבר פי 3 מהנורמה. איזה מבין המצבים הבאים יכול להסביר את הרמה הגבוהה של הפרולקטין?

א. Hyperthyroidism
ב. Diabetes mellitus type 1
ג. Fluoxetine treatment
ד. Beta blocker treatment

20. בן 62, ברקע יתר לחץ דם מאוזן. בשבועות האחרונים מתלונן על חולשה, חום 37.5^0C, כאב ראש פרונטלי, שיעול וירידה במשקל של 2 ק"ג. ב- CT חזה ground glass opacities ומספר גרנולומות דו"צ. במעבדה - קריאטינין 3 מ"ג/ד"ל (בסיס 0.8), RF,ANA שליליים, משלים תקין, PR3 חיובי בכייל גבוה, במשקע שתן ריבוי אריטרוציטים ויחס חלבון/קריאטינין 1.5. בביופסיית כליה crescentic glomerulonephritis. מה צפוי למצוא באימונופלורסנציה?

א. העדר שקיעה של קומפלקסים אימוניים
ב. שקיעה של IgG, IgM, C3 ו- C1q
ג. שקיעה ליניארית של IgG
ד. משקעים מזנגיאליים של IgA

21. איזה מבין הטיפולים הבאים הדגים יעילות נמוכה משמעותית בטיפול ב- rheumatoid arthritis בהשוואה לטיפולים ביולוגיים אחרים?

א. Adalimumab
ב. Rituximab
ג. Anakinra
ד. Tocilizumab

22. בן 73, מעשן כבד, עלה מדרום אמריקה לפני 30 שנה שם עבד במכרה כעשרים שנה. פנה לבירור בשל קוצר נשימה שגובר בחודשים האחרונים, מלווה בירידה במשקל וכיח דמי. איזה ממצא בצילום חזה יתמוך בחשד למזותליומה?

א. פלאקים פלאורלים ללא תפליטים
ב. הצללות דו"צ אינטרסטיציאליות בבסיסי הריאות עם ברונכיאקטזיות משיכה
ג. ממצא עגול בעל גבולות לא חדים בריאה ימנית עליונה
ד. תפליט פלאורלי בינוני מימין

23. במי מהמטופלים הבאים יש לבדוק נוכחות של *Helicobacter pylori* ע״י אנטיגן בצואה/מבחן נשיפה?

א. בן 70 עם hemolytic anemia
ב. בת 65 עם טיפול ממושך ב-NSAIDs
ג. בת 18 עם סיפור משפחתי של *Helicobacter pylori*
ד. בן 75 עם dyspepsia

24. בן 80, ברקע סוכרת, יל״ד, דיסליפידמיה, עישון של 60 שנות קופסא וכבד שומני. בדיקתו הגופנית תקינה. בבדיקות מעבדה שגרתיות - לויקוציטוזיס 152,000,לימפוציטים 143,000, המוגלובין 11.5 ג׳/ד״ל, טסיות 147,000 בממ״ק, קריאטינין 1.1 מ״ג/ד״ל, LDH – 679. ב- FACS מדם היקפי ריבוי תאים חיוביים ל CD5, CD19, CD23 CD20 ושליליים ל CD10. מה ההמלצה למטופל?

א. מעקב בלבד
ב. טיפול ע״י מעכבי Bruton kinase (BTK)
ג. טיפול ע״י מעכבי PI3K
ד. טיפול ע״י Rituximab

25. בת 65, אובחנה לפני כ-6 חודשים כסובלת ממלנומה ולפני חודשיים החלה טיפול ב-nivolumab. במעקב שגרתי נמצאו : ALT - 450, AST – 250, בילירובין 2.5 מ״ג/ד״ל. מה צפוי להימצא בנוסף?

א. ערכי C3 נמוכים
ב. תמונה פתוגנומונית בביופסיית כבד
ג. טיטר ANA חיובי גבוה
ד. רמות גלובולינים נמוכות

26. בת 40, מאושפזת עקב פיילונפריטיס. בתרביות השתן והדם צמיחה של *E. coli*, עמיד ל- trimethoprim-sulfamethoxazole ורגיש לכל התרופות האחרות שנבדקו. איזה מהמשפטים הבאים לגבי יעילות הטיפול האנטיביוטי הוא הנכון ביותר?

א. טיפול תוך ורידי ב- quinolone יעיל יותר מטיפול פומי
ב. לטיפול של 14 ימים תוצאות טובות יותר מטיפול של 7 ימים
ג. טיפול פומי ב- beta lactam יעיל פחות מטיפול ב- quinolone
ד. fosfomycin פומי לשבועיים הוא טיפול מקובל ויעיל במצב זה

27. איזה מבין גורמי הסיכון הבאים הוא גורם הסיכון המשמעותי ביותר לחלות בשחפת פעילה במטופלים עם שחפת סמויה?

א. טיפול בנוגדי TNF
ב. זיהום ב-HIV
ג. עישון
ד. טיפול ב- TKI

28. בן 63, ברקע COPD. כשאובחנה מחלתו לפני 5 שנים הפסיק לעשן לאחר 40 שנות קופסא. כעת מאושפז לראשונה בשל התלקחות מחלתו הבסיסית ומטופל כמקובל. בתפקודי הריאות מהחודש האחרון FEV1 65% מהצפוי, FEV1/FVC 0.68. כעת, ללא חמצת בבדיקת גזים בדם. מה צפוי שימצא בנוסף?

א. ערך $PaCO_2$ בבדיקת גזים עורקיים יהיה מעל 45mmHg
ב. באקו לב תהיה עדות ליתר לחץ דם ריאתי
ג. ערך PaO_2 בבדיקת גזים עורקיים יהיה מעל 55mmHg
ד. בספירת דם נמצא המוגלובין 17 ג'/ד"ל

29. איזה מבין המצבים הבאים עלול לגרום לעיתים קרובות לאי ספיקת כליות חדה עם FENa נמוך מ-1%?

א. Glomerulonephritis
ב. Fanconi syndrome
ג. Acute interstitial nephritis
ד. Light chain cast nephropathy

30. בן 80, מאובחן כסובל מ CLL מזה 6 שנים על סמך לימפוציטוזיס 50,000 בממ"ק. עד כה א-תסמיני. מתקבל כעת בגלל חולשה, טכיקרדיה, נשמת 25 בדקה וצהבת בלחמיות. במעבדה: לימפוציטוזיס 60,000 בממ"ק, המוגלובין 6 ג'/ד"ל, רטיקולוציטוזיס, Coombs חיובי והפטוגלובין אפסי. מה הצעד המיידי שיש לבצע?

א. להשלים בדיקת מח עצם לצורך החלטה על טיפול
ב. להתחיל טיפול בסטרואידים
ג. להתחיל טיפול ב- rituximab
ד. להתחיל טיפול במעכב BTK

31. בן 45 ברקע SLE ותסמונת APLA עם אירוע של DVT בעברו. מפסיק את הטיפול הקבוע ב- warfarin למשך 5 ימים לצורך ביצוע גסטרוסקופיה. יום לאחר הפעולה מתלונן על כאבי בטן עזים ובבדיקה בטן רגישה ללא סימני גירוי ציפקי. רגל ימין תפוחה.

במעבדה: המוגלובין 9.5 ג'/ד"ל, טסיות 60,000 בממ"ק, לויקוציטים 8,000 בממ"ק, קריאטינין 2.5 מ"ג/ד"ל [בסיס 0.8], LDH - 1200 יח' ובילירובין 2.5 מ"ג/ד"ל. ב CT בטן - 2 אוטמים במראה טרי בטחול, אוטם בכליה ימין. בדופלקס: DVT מימין.

בנוסף ל- heparin, מה הטיפול **הדחוף** הנכון כעת?

א. Rituximab
ב. Plasma exchange + methylprednisolone
ג. IVIg + acetylsalicylic acid
ד. Eculizumab + plasma exchange

32. בת 57, ברקע סוכרת, אוסטאופורוזיס ואסתמה. לאסתמה מטופלת במשאף ICS/LABA במינון מוגבר פעמיים ביום. איזה מהבאים היא נמצאת בסיכון מוגבר לפתח?

א. קושי באיזון סוכרת
ב. החמרה באוסטאופורוזיס
ג. התפתחות יתר לחץ דם
ד. זיהום HSV בחלל הפה

33. בן 65 ברקע מחלת כליות סופנית על רקע סוכרת. מטופל בהמודיאליזה. מדווח על חשיפה לחולה שחפת במשפחה. בתבחין טוברקולין (מנטו/PPD) אינדורציה של 8 מ״מ, צילום חזה תקין. מה הטיפול המומלץ ביותר במצבו?

א. rifampin ו- isoniazid לחודשיים
ב. rifampin ו- isoniazid לתשעה חודשים
ג. rifampin לשישה חודשים
ד. isoniazid לשישה חודשים

34. מה נכון לגבי ההשוואה בין low molecular weight heparin (LMWH) ל- fondaparinux?

א. הפינוי של LMWH בעיקרו כלייתי וזה של fondaparinux בעיקרו כבדי
ב. protamine sulfate מנטרל חלקית LWMH ולא משפיע על fondaparinux
ג. הסיכון לפתח osteoporosis זהה בשניהם
ד. זמן מחצית החיים של LMWH ארוך יותר מזה של fondaparinux

35. בן 50 ללא מחלות רקע ידועות, פונה למלר״ד בשל כאבי בטן. לחץ דם 115/75, יציב נשימתית. בטן מעט רגישה. בדיקות מעבדה רוטיניות – תקינות. ב- CT בטן ממצא באדרנל בקוטר 2 ס״מ בצפיפות נמוכה מ- 20HU. כאבי הבטן חלפו בינתיים. מה נכון לגבי המשך הבירור?

א. יש לבצע בדיקת סקר ל- hyperaldosteronism
ב. אין צורך בהמשך בירור
ג. יש לבצע בדיקת סקר ל- hypercortisolism
ד. יש לבדוק רמות 17 hydroxyprogesterone ואנדרוגנים אדרנלים

36. בן 54 מועמד לטיפול ב- R-CHOP בשל high grade non Hodgkin lymphoma.
בבדיקות סקר ל- HBV נמצאו: HBsAg שלילי, anti HBc חיובי. אנזימי כבד תקינים.
כיצד יש להתייחס לממצאים אלו?

א. אין צורך בטיפול אנטיויראלי מניעתי
ב. יש להתחיל טיפול אנטיויראלי מניעתי ולהמשיכו 6-12 חודשים מסיום הטיפול הכימותרפי
ג. יש להתחיל בטיפול מלא לארדיקציה של HBV
ד. יש לבצע בדיקת PCR ועל פי תוצאותיה להחליט על הטיפול הרצוי

37. בן 50, ללא טיפול תרופתי קבוע, מאושפז בשל renal colic על רקע אבן בכליה השמאלית. באנליזה של האבן נמצא כי מדובר באבן מסוג calcium oxalate. במעבדה: קריאטינין 0.8 מ"ג/ד"ל, סידן בדם 9.8 מ"ג/ד"ל, אלבומין 4.6 ג/ד"ל, ALP 74. באיסוף שתן 24 שעות - נפח 2000 מ"ל, סידן 480 מ"ג. מה הגישה הטיפולית הנכונה?

א. הגבלת צריכת סידן ל- 400 מ"ג ליממה והעשרת חלבון מהחי
ב. טיפול אנטיביוטי ב-rifaximin
ג. דיאטה עשירה בסידן (כ- 1200 מ"ג ביממה)
ד. דיאטה עתירת מלח

38. בת 83, ברקע היפרליפידמיה, יל"ד ואוסטאופורוזיס. מזה 3 ימים קושי וכאב בעת בליעת מוצקים ללא קושי בבליעת נוזלים. ללא שיעול או רגורגיטציה. איזו מבין האבחנות הבאות היא הסבירה ביותר?

א. Pill esophagitis
ב. Peptic stricture
ג. Achalasia
ד. Zenker's diverticulum

39. מה נכון לגבי דמנציה?

א. בכ- 20% מהמקרים קיימת סיבה הפיכה
ב. השמנה היא גורם מגן בפני דמנציה
ג. לרמת ההשכלה אין כל השפעה על שכיחות האבחנה
ד. לעישון אין כל השפעה על שכיחות האבחנה

40. בת 50, בריאה בד"כ, הופנתה למלר"ד בשל טרומבוציטופניה של 25,000 בממ"ק ללא הפרעה בשורות הדם הנוספות. ללא סימני דמם. מה ההמלצה לחולה כעת?

א. בדיקת מח עצם
ב. טיפול ומעקב אמבולטורי
ג. חיסון ל- *Streptococcus pneumonia*
ד. טיפול חד פעמי ב- IVIg

41. בן 68, ביצע אק"ג במסגרת בדיקת סקר מנהלים. התוצאות מוצגות **בתמונה 5**. מה המשך הבירור ו/או הטיפול הנדרשים?

א. יש להשלים בירור בחשד למחלה אינפילטרטיבית
ב. יש לבצע מבחן מאמץ על מנת לנסות ולקבוע את הצורך בקוצב לב
ג. חובה לבצע בדיקה אלקטרופיזיולוגית כדי לקבוע את המשך הטיפול
ד. המטופל זקוק להשתלת קוצב לב

42. בת 74 הסובלת מאוסטאופורוזיס פונה לבדיקה בגין כאבי גב עזים. צפיפות העצם הדגימה החמרה משמעותית. בהדמיה כעת שברי דחיסה ב L3-L4-L5. לפני כשנה סיימה טיפול ממושך בזריקות לטיפול באוסטאופורוזיס והומלץ לה להמשיך טיפול בתכשיר אחר, אך היא החליטה שלא ליטול אותו. באיזה ממשטרי הטיפול סביר שטופלה?

	הטיפול עד לפני שנה	הטיפול שהומלץ אך לא ניטל
א.	zolendronic acid	teriparatide
ב.	denosumab	alendronate
ג.	teriparatide	zolendronic acid
ד.	romosozumab	denosumab

43. איזה מבין המשפטים הבאים נכון לגבי אבחנה של סרקואידוזיס?

א. בחולה עם מחלת ריאות אינטרסטיטיאלית, לימפאדנופתיה משמעותית במיצר (מעל 2 ס״מ) מעלה את הסיכוי כי זו אכן האבחנה
ב. רמות ACE נמוכות שוללות בסבירות גבוהה את האבחנה
ג. שילוב ממצאים של noncaseating granuloma ו- BAL lymphocytosis פי שניים מהנורמה הוא פתוגנומוני
ד. אופייני במצב זה יחס CD4/CD8 נמוך מ- 3.5

44. איזה מבין הבאים הוא סיבוך אפשרי של polycythemia vera?

א. Maltoma
ב. Peptic ulcer disease
ג. Blue toe
ד. Alopecia

45. בן 67, בריא בד"כ. ברקע בצעירותו עישון של 10 שנות קופסא. פונה לבירור עקב שיעול יבש וקוצר נשימה במאמץ. תפקודי ריאה מדגימים הפרעה רסטריקטיבית בינונית עם ירידה בדיפוזיה. אקו לב תקין. ב CT חזה הצללות רטיקולריות תת פלאורליות בזליות עם סימני חלת דבש וברונכיאקטזיות משיכה. מה האבחנה הסבירה ע"פ נתונים אלו?

א. Nonspecific interstitial pneumonia
ב. Pulmonary sarcoidosis
ג. Hypersensitivity pneumonitis
ד. Idiopathic pulmonary fibrosis

46. בת 65, מתאשפזת בשל חום ופאנציטופניה. במעבדה: IL2 receptor – 5000U/ml, PCR EBV מעל מליון עותקים. אילו מבין הממצאים הבאים יתמכו באבחנה **הסבירה ביותר** למצבה?

א. פריטין מוגבר עם היפרפיברינוגנמיה
ב. פריטין מוגבר עם פעילות NK cells מוגברת
ג. היפופיברינוגנמיה עם כבד מוגדל באולטראסאונד בטן
ד. פריטין מוגבר וטחול מוגדל שנמוש 3 ס"מ מתחת לקשת הצלעות

47. איזה מבין הטיפולים הבאים מומלץ כטיפול במורסה (abscess) ריאתית ראשונית?

א. ceftriaxone
ב. metronidazole
ג. ניקוז ו- ciprofloxacin
ד. amoxicillin-clavulanate

48. בן 50, מאושפז בשל הקאות עם תוכן "קפה טחון". בבדיקתו חיוור, ל"ד 110/80, דופק 95 לדקה, סטורציה 95% באוויר חדר ובטן רכה ללא רגישות. במעבדה: המוגלובין 9.5 ג'/ד"ל ובגסטרוסקופיה כיב בבצל התריסריון עם כלי דם מדמם שנצרב. מה נכון לגבי מצבו?

א. יש לתת לו כעת 2 מנות דם ואז ניתן לשחררו לביתו
ב. לאחר הפעולה עירוי PPI אינטרמיטנטי יעיל פחות מעירוי מתמשך
ג. לאחר הפעולה האנדוסקופית ניתן להחזירו לאכילת מוצקים
ד. יש צורך באשפוז של לפחות 3 ימים סביב הפעולה האנדוסקופית

49. מה סביר למצוא בבדיקות העזר של בת 48 שמאובחנת כסובלת מ- chronic hypersensitivity pneumonitis?

א. DLCO תקין
ב. לימפוציטוזיס ב- BAL
ג. אמפיזמה בביופסיה טרנסברונכיאלית
ד. אאוזינופיליה היקפית

50. בן 80, עם יתר לחץ דם, מחלת לב איסכמית, החלפת מסתם מיטרלי למסתם מכני ואי ספיקת כליות סופנית המטופלת בהמודיאליזה. סובל מנגע עורי נקרוטי כואב מאוד בירך שמאל **(תמונה 6)**. איזה תרופה יש להפסיק באופן מיידי?

א. clonidine
ב. cinacalcet
ג. warfarin
ד. sevelamer

51. בת 28, מטופלת בתרופה ונמצאת במעקב אלקטרוקרדיוגרפי בשל כך **(תמונה 7)**. באיזו תרופה מדובר?

א. Doxycycline
ב. Chloroquine
ג. Chloramphenicol
ד. Pyrimethamine

52. איזה מבין הטיפולים הבאים מומלץ כטיפול תומך באירוע מוחי איסכמי חד בחולה סוכרתי שאיננו מועמד לקבל טיפול טרומבוליטי?

א. הורדת לחץ דם סיסטולי לערכים מתחת ל- 185 ממ״כ
ב. איזון סוכר קפדני לערכים בין 80 ל- 140 מ״ג/ד״ל
ג. הורדת חום
ד. מתן סטרואידים

53. בן 20 חולה ב- FMF המתבטא בהתקפים חוזרים של כאבי בטן וחום ולעיתים גם כאבים פלאוריטים וכאבי מפרקים. מטופל ב- colchicine במינון של 2 מ״ג ליממה ועדיין סובל מתסמינים אחת לחודשיים. מתקבל כעת עם כאב בטן, חום וכאב מפרקים. בבדיקתו הממצא **בתמונה 8.** איזו מבין התרופות הבאות תתאים כטיפול לאבחנה הסבירה ביותר?

א. IV cefazolin
ב. IV heme arginate
ג. SC. canakinumab
ד. PO. allopurinol

54. בן 24 פונה למלר"ד בשל חולשה. בבדיקתו טכיקרדיה, שאר הבדיקה ללא ממצאים. במעבדה היפרלויקוציטוזיס, לימפוציטוזיס, אנמיה וטרומבוציטופניה. בבדיקת מח עצם ממצאים המצביעים על אבחנה של B-ALL. איזה ממצא ישפיע בצורה המשמעותית ביותר על בחירת הטיפול?

א. לויקוציטוזיס מעל 30 אלף
ב. נוכחות טרנסלוקציה (9,22)
ג. אחוז הבלסטים במח עצם
ד. עומק הטרומבוציטופניה

55. מה נכון לגבי טיפול באירוע ראשון של *C. difficile* colitis?

א. IV fidaxomicin היא התרופה היעילה ביותר
ב. במחלה חמורה יש להוסיף IV vancomycin
ג. רזולוציית השלשול זהה עם טיפול ב- fidaxomicin או vancomycin
ד. בהעדר רזולוציה של השלשול יש להמיר את האנטיביוטיקה לאחר 4 ימי טיפול

56. בן 60, ברקע אוסטאוארתריטיס ויתר לחץ דם. מטופל ב-NSAIDs ומעכבי ACE זמן ממושך. מזה כחודש מתלונן על כאב ברום הבטן המוחמר לאחר אכילה וכעת החמרה ניכרת בכאב עם התפשטות לכל הבטן. בבדיקה: מתנשם, ל"ד 130/90, דופק 90 לדקה סדיר, ללא חום, רגישות דיפוזית במישוש הבטן. צילום חזה **בתמונה 9**. מה נכון לגבי סיבוך זה של מחלתו?

א. מדובר בסיבוך הנפוץ ביותר במטופלים מעל גיל 60
ב. שיעורי התמותה הצפויים הם מעל 20% בתוך 30 יום
ג. הסיבה הנפוצה לסיבוך זה כיום היא זיהום ע"י *H. pylori*
ד. לאחרונה קיימת ירידה בשכיחות סיבוך זה במבוגרים

57. בת 38, ללא רקע רפואי ידוע, פונה לבירור בשל פליטת ליחה מרובה. ב- CT חזה: ברונכיאקטזיות מפושטות. מה ההמלצה כעת?

א. הפניה בהקדם לברונכוסקופיה אבחנתית
ב. טיפול בסטרואידים סיסטמיים למשך 14-10 יום
ג. הפניה בהקדם לבדיקת EBUS (endobronchial ultrasound)
ד. הפנייה לפיזיותרפיה נשימתית

58. מה נכון לגבי ניהול מקרה בקטרמיה של *Pseudomonas aeruginosa*?

א. טיפול אנטיביוטי במשך שבוע בדרך כלל מספיק
ב. במרבית המקרים יש הכרח לטפל ב - combination therapy
ג. יש להמשיך לתרבת כדי לוודא ארדיקציה גם אם מצב המטופל משתפר
ד. יש להקפיד על בידוד מגע בכל המטופלים עד סיום הטיפול

59. בת 42, בריאה בד"כ, פונה למלר"ד בשל כאב ראש עורפי חזק שהחל לפני כשעתיים. בעת שהותה במלר"ד מתפתח בנוסף גם קושי בדיבור. איזו בדיקה יש לבצע כעת על מנת להגיע לאבחנה **<u>הסבירה</u>** ביותר?

א. CTA של עורקי הצוואר
ב. LP
ג. CT של עמ"ש צווארי
ד. EEG

60. מה נכון לגבי טיפול ב - ESAs (erythropoietin stimulating agents) במטופלים סוכרתיים עם אנמיה ו-CKD מתקדם?

א. קיימת אסוציאציה בין הטיפול ב-ESAs לסיכון טרומבואמבולי מוגבר וסיכון לשבץ
ב. מטרת הטיפול להעלות המוגלובין מעל 13 גרם/ד"ל בגברים ומעל 12 גרם/ד"ל בנשים
ג. מחקרים רנדומליים מבוקרים הראו שהטיפול משפר תוצאים קרדיווסקולריים
ד. הקפדה על רמת פריטין מתחת ל-100 נ"ג/מ"ל מצמצמת את תופעות הלוואי של הטיפול

61. בן 70 מתלונן על כאב ראש טמפורלי משמאל, חולשה, חום $37.5^{0}C$, כאב בחגורת הכתפיים וללא תלונות עיניות. בבדיקתו: רגישות ניכרת במישוש עורק טמפורלי משמאל, בדיקת עיניים תקינה. במעבדה: אנמיה נורמוציטית 12 ג'/ד"ל (בסיס 14), שקיעת דם 100 מ"מ בשעה. CTA מוח תקין. מה יש לעשות כעת?

א. לאשפז ולהתחיל מיד טיפול ב- IV methylprednisolone 1000mg/day
ב. לשחרר ללא טיפול למעקב ראומטולוגי אמבולטורי
ג. להתחיל prednisone 40-60 מ"ג ליום ולתאם ביופסיה טמפורלית תוך שבועיים
ד. לאשפז לצורך ביופסיה טמפורלית ללא התחלת טיפול

62. בן 48, מתלונן על יובש בפנים, קוצר נשימה ושיעול בשבועות האחרונים. פניו **בתמונה 10**. מה תצפו למצוא בנוסף?

א. בדיקת VDRL חיובית
ב. הצללה ריאתית אפיקלית
ג. תפליט פלאורלי משמאל
ד. לשון גדולה ואדומה

63. איזה מבין הממצאים הבאים תומך באבחנה של Autoimmune Hepatitis?

א. טיטר גבוה של נוגדנים מסוג Anti-mitochondrial Ab
ב. עלייה ברמת immune globulin G
ג. עלייה ניכרת של alkaline phosphatase
ד. הסננה שומנית בבדיקה היסטולוגית של הכבד

64. בן 39 מושתל כליה, מטופל ב-tacrolimus, prednisone, mycophenolic acid. אושפז לבירור לימפאדנופתיה צווארית. בפתולוגיה נמצא שמדובר ב- squamous cell carcinoma ממקור עורי. איזה שינוי בטיפול התרופתי סביר לשקול כעת?

א. הפסקת prednisone באופן מיידי
ב. החלפת mycophenolic acid ב-azathioprine
ג. החלפת tacrolimus ב-everolimus
ד. החלפת mycophenolic acid ב- belatacept

65. זמן מחצית החיים של gentamycin הוא כ- 75 ד' ואילו זמן מחצית החיים של cefazolin הוא כ- 100 ד'. מדוע אם כך אנו מטפלים במנה חד יומית של האנטיביוטיקה הראשונה וב- 3-4 מנות יומיות של השנייה?

א. כיוון ש- cefazolin רעיל במינונים גבוהים
ב. כיוון שפעילות cefazolin תלוית מינון (dose-dependent) ובעלת אפקט בקטריוצידי
ג. כיוון ש- cefazolin בקטריוסטטי ובעל post-antibiotic effect
ד. כיוון שפעילות cefazolin תלוית זמן (time-dependent) וללא post-antibiotic effect

66. בן 80 עם כאבי גב תחתון ו- carpal tunnel syndrome, פונה לבירור בשל קוצר נשימה במאמצים. במהלך הבירור בוצע אק״ג שמוצג **בתמונה 11**. מה סביר למצוא בבדיקת אקו לב?

א. pericardial effusion גדול
ב. mitral regurgitation חמור
ג. longitudinal strain שמור יתר באפקס
ד. outflow tract obstruction של חדר שמאל

67. בן 71, ברקע cardiac cirrhosis. מתאשפז בשל דה-קומפנצסיה כבדית ומיימת ניכרת. במעבדה: קריאטינין 2.9 מ״ג/ד״ל (ערך קודם 2 מ״ג/ד״ל), אוריאה 270 מ״ג/ד״ל, אלבומין 2.1 ג׳/ד״ל, נתרן 135 מא״ק/ל. בגזים: pH – 7.36 pCO_2 35 mmHg, ביקרבונט 20 מא״ק/ל וכלור 105 מא״ק/ל. מה הפרעת החומצה בסיס ממנה סובל המטופל?

א. normal anion gap metabolic acidosis עם בססת נשימתית קלה
ב. normal anion gap metabolic acidosis
ג. high anion gap metabolic acidosis
ד. high anion gap metabolic acidosis בשילוב עם metabolic alkalosis

68. כל הבאים מהווים חלק מהפרוטוקול הטיפולי האקוטי בהיפרקלמיה פרט ל:

א. IV $NaHCO_3$ 50 ml over 5 minutes
ב. IV Furosemide 40 mg - push
ג. IV Insulin 10 U - push
ד. IV Calcium gluconate 10% 10 ml over 2-3 minutes

69. בן 43, פועל במפעל אבן קיסר, פונה לבירור בשל שיעול דמי חדש שהופיע בשבועות האחרונים. ב-CT חזה מודגמת לימפאדנופתיה מדיאסטינלית והילארית מסויידת בתבנית של "egg shell" והצללות נודולריות מפושטות דו"צ. איזו מחלה עלולה להתגלות במטופל זה בשכיחות מוגברת?

א. Lung tuberculosis
ב. Granulomatous with polyangiitis
ג. Pulmonary embolism
ד. Eosinophilic granulomatous and polyangiitis

70. בן 82, סובל מדמם תוך מוחי תחת טיפול ב acetylsalicylic acid ו- rivaroxaban. ספירת דם ותפקודי כליה תקינים. מה הטיפול המומלץ ביותר כעת? (סמן את התשובה המדויקת ביותר)

א. טסיות ו- andexanet alfa
ב. andexanet alfa
ג. טסיות ו- PCC
ד. PCC

71. איזה מבין הבאים מהווה גורם סיכון מובהק להתפתחות מנינגיטיס פנאומוקוקלית?

א. חסרים במערכת המשלים (C5-C9)
ב. שהייה במקומות צפופים כגון מעונות
ג. שבר בגולגולת
ד. טיפול כרוני בסטרואידים

72. מה הטיפול המומלץ לבן 80, המרותק למיטה ומאובחן כסובל מ- pseudo colonic obstruction ללא חסימה מכנית?

א. Neostigmine
ב. Clonidine
ג. Diclofenac
ד. Methylene blue

73. בת 27, ברקע מחלת קרוהן ידועה מזה מספר שנים. בשנים האחרונות ברמיסיה תחת טיפול ב-adalimumab. כעת בשבוע 8 להריון. איזה מהמשפטים הבאים נכון בהקשר לניהול המקרה ?

א. יש להמליץ על הפסקת הטיפול התרופתי בשל סיכון גבוה להפלה, יש לשקול שימוש בסטרואידים במידת הצורך
ב. יש לשקול הפסקת הריון בשל טרטוגניות של הטיפול שקיבלה עד עתה
ג. יש להמליץ על החלפת הטיפול התרופתי ל-vedolizumab בשל פרופיל הבטיחות של התרופה בהריון
ד. יש להימנע ממתן חיסונים חיים לתינוק/ת עד גיל שנה

74. בן 30 פונה לייעוץ עקב חשיפה לבן זוג אשר חלה בעבר בסיפיליס, אך לא ברור מתי טופל. כעת מדווח על פריחה מוזרה על הגוף שהתחילה לפני שבוע. במעבדה: TPHA חיובי ו-VDRL שלילי. מה מדיניות הטיפול בו?

א. IM penicillin G benzathine 2.4 mU – חד פעמי
ב. אין צורך בטיפול
ג. IM penicillin G benzathine 2.4 mU כל שבוע למשך 3 שבועות
ד. IM penicillin G benzathine 2.4 mU בכל עכוז (סך הכל 4.8 mU) באופן חד פעמי

75. כל התרופות הבאות מומלצות כטיפול לציסטיטיס פשוט בנשים פרט ל:

א. Ciprofloxacin
ב. Nitrofurantoin
ג. Amoxicillin-clavulanate
ד. Trimethoprim-sulfamethoxazole

76. בן 64 בצום. מצורפות תוצאות בדיקות המעבדה שלו: קריאטינין 2.1 מ"ג/ד"ל, גלוקוז 120 מ"ג/ד"ל, נתרן 146 מא"ק/ל, אשלגן 2.9 מא"ק/ל, סידן 9.1 מ"ג/ד"ל, אלבומין 4 ג/ד"ל. מאיזו תמיסה במתן תוך ורידי מומלץ להימנע במקרה זה?

א. Ringer`s lactate
ב. Saline 0.9% + KCl 40 mEq
ג. Saline 0.45% +KCl 20 mEq+ Dextrose 5%
ד. Saline 0.45% +KCl 40 mEq

77. מה המינון <u>המקסימלי</u> המומלץ של מעכבי SGLT2 לטיפול באי ספיקת לב?

א. empagliflozin 25mg פעם ביום
ב. dapagliflozin 25mg פעם ביום
ג. empagliflozin 10mg פעם ביום
ד. dapagliflozin 10mg פעמיים ביום

78. מה נכון לגבי נוגדנים ב- SLE?

א. ANA חיובי הוא ספציפי לאבחנה של SLE
ב. ANA לא מהווה בדיקת סקר טובה ל- SLE
ג. Anti RO חיובי קשור לביטוי קליני של subacute cutaneous lupus
ד. אין קשר בין רמת נוגדן Anti ds-DNA ובין פעילות המחלה ב- SLE

79. בן 65, מאושפז בשל התלקחות COPD. איזה מהטיפולים הבאים יוביל בסבירות גבוהה להארכת חייו?

א. שימוש ב Non-invasive ventilation אם PaCO2>45mmHg
ב. מתן מאקרוליד לסירוגין במהלך האשפוז ולאחר השחרור
ג. טיפול בסטרואידים סיסטמיים ל 5-10 ימים
ד. טיפול בסטרואידים בשאיפה בזמן ההתקף החד

80. איזו מבין התרופות הבאות היא המומלצת לשימור מקצב במטופל בן 70 הסובל מפרפור עליות וקרדיומיופתיה איסכמית (מקטע פליטה – 35%)?

א. Dronedarone
ב. Sotalol
ג. Flecainide
ד. Propafenone

81. בת 77, לאחר אוטם שריר הלב. משנית לכך LVEF 45% ו- severe mitral regurgitation. תרשים אק"ג **בתמונה 12**. תחת טיפול תרופתי מיטבי לאי ספיקת לב עדיין NYHA II-III. בהנחה שלמטופלת אנטומיה מתאימה, איזה טיפול **הכי** נכון להציע לה?

א. תיקון מלעורי של המסתם ע"י קליפ
ב. CRT (cardiac resynchronization therapy)
ג. החלפה ניתוחית של המסתם
ד. הוספת אנטיקואגולציה

82. למי מבין המטופלים הבאים קיימת התווית נגד לטיפול ב- sertraline?

א. בן 64 שמטופל ב- linezolid
ב. בן 71 שמטופל ב- atorvastatin
ג. בן 25 המאושפז בשל HIV אקוטי
ד. בן 59 שמטופל ב- ceftriaxone

83. בן 25 מתקבל למחלקה בשל כאבי מפרקים גדולים, נודדים, אסימטריים. באנמנזה מתברר כי לפני כשבועיים חלה במחלה שלשולית שחלפה. מה הפרוגנוזה של המחלה ממנה הכי סביר שסובל?

א. מחלתו תחלוף, סביר להניח, תוך מספר ימים
ב. יש סיכוי משמעותי כי יפתח sacroiliitis
ג. יש סיכוי של פחות מ- 10% כי יפתח תסמינים כרוניים
ד. אירועים חוזרים של המחלה – נדירים

84. מה נכון לגבי טיפול עם Direct Anti-viral Agents (DAA) ב- HCV?

א. אין התוויה להוספת ribavirin לטיפול ב- DAA
ב. אין התוויה לטיפול ב-DAA בחולים עם אנזימי כבד תקינים ופיברוזיס בדרגה נמוכה
ג. אין להשתמש ב- DAA המכילים מעכבי פרוטאז בחולים עם שחמת לא מפוצה
ד. אין התוויה לטיפול ב-DAA בחולים עם acute HCV

85. בן 24, חזר מטיול תרמילאים בהודו. מתאשפז עקב חום $39^{o}C$, דופק 70 לדקה, כאבי בטן מפושטים ; בספירת דם – לויקופניה. איזה מבין הטיפולים הבאים הוא הטיפול האמפירי המתאים ביותר?

א. Ciprofloxacin
ב. Azithromycin
ג. Metronidazole
ד. Amoxicillin – clavulanate

86. בבירור קוצר נשימה של מטופלת בת 54 ללא מחלות רקע מתקבלת תשובה היסטולוגית של nonspecific interstitial pneumonia. מה נכון לגבי הפרוגנוזה של מחלתה?

א. יכולה להגיע למעל 80% הישרדות ל 5 שנים
ב. דומה לפרוגנוזה של idiopathic pulmonary fibrosis
ג. הימצאות נוגדן חיובי ל connecting tissue disease משפר סיכויי הישרדות לעומת המחלה האדיופטית
ד. לתצורת המחלה הפיברוטית פרוגנוזה טובה יותר מאשר לתצורה התאית (cellular)

87. מה נכון לגבי פגיעה כלייתית משנית לטיפול ב-immune checkpoint inhibitor?

א. נגרמת בכ- 15-20% מהמטופלים
ב. שכיחה יותר במטופלים הנוטלים PPI
ג. מנגנון הפגיעה השכיח הוא glomerulonephritis
ד. מנגנון הפגיעה השכיח הוא renal-limited thrombotic microangiopathy

88. בן 50, מבצע קולונוסקופיה כבדיקת סקר. בבדיקה נמצאו 5 אדנומות שנכרתו באופן מלא. בהיסטולוגיה: villous adenoma. מתי מומלץ לחזור על קולונוסקופיה?

א. בעוד 6 חודשים
ב. בעוד שנה
ג. בעוד שנתיים
ד. בעוד 3 שנים

89. איזה מהתסמינים הבאים מהווה ביטוי אפשרי של נוירופטיה אוטונומית בחולים סוכרתיים?

א. ברדיקרדיה במנוחה
ב. בריחת שתן
ג. הזעת יתר בגפיים התחתונות
ד. עליה בוריאביליות של קצב הלב

90. בן 92, עסק בתעשיית הנפט בבריה"מ. לאחרונה אובחן כסובל מ myelodysplastic syndrome (MDS). בספירת הדם אנמיה מאקרוציטית וטרומבוציטופניה. מה נכון לגבי מאפייני מחלתו?

א. צפוי למצוא טחול מוגדל בבדיקה גופנית
ב. קיים סיכוי שיפתח תופעות אוטואימוניות
ג. צפויים דימומים רק במידה והטרומבוציטופניה קשה
ד. צפוי למצוא Erythema nodosum בבדיקה הגופנית

91. זיהום ממקור נשימתי מלווה בהצללות דו"צ בצילום חזה, במטופל מושתל כליה, עלול להיגרם ע"י כל המחוללים הבאים, פרט ל:

א. CMV
ב. BK virus
ג. Pneumocystis jirovecii
ד. Cryptococcus

92. בן 25 פונה על ידי אמבולנס לבית החולים בעקבות אירוע של אובדן הכרה חולף. לפני כשבוע סבל ממחלת חום מלווה בכאבים בחזה. בוצע אק"ג במרפאה שמוצג **בתמונה 13**. איזה ממצא יעיד על סיבוך אופייני למחלה?

א. התגברות של אוושה סיסטולית באקספיריום
ב. התגברות של אוושה סיסטולית באינספיריום
ג. העלמות דופק פריפרי באקספיריום
ד. העלמות דופק פריפרי באינספיריום

93. בת 72 הרגישה קוצר נשימה בזמן צפייה בחדשות. במלר"ד אבחנה של בצקת ריאות ובתרשים האק"ג עליות ST בחיבורים תחתונים וב- V1-V4. בצנתור נמצאו עורקים כליליים ללא היצרות משמעותית והזרקת חומר ניגוד לחדר שמאל מודגמת **בתמונה 14**. מה נכון לגבי הפרוגנוזה שלה?

א. שעור הסיבוכים והתמותה המידיים דומה לשיעורם בחולה הסובל מאוטם שריר הלב
ב. האירוע עלול לחזור ב- 20% מהחולים
ג. הפרוגנוזה ארוכת הטווח דומה לזו של חולים עם קרדיומיופטיה איסכמית
ד. יש סיכוי של יותר מ- 25% לפתח הפרעות הולכה במהלך האשפוז

94. בן 63 מתקבל בשל ספירת דם כדלקמן : 156,000 לויקוציטים בממ״ק, שמתוכם 103,000 נויטרופילים, 1600 אאוזינופילים, 3100 באזופילים, 4700 מונוציטים. המוגלובין 12.9 ג׳/ד״ל עם MCV 102 וטסיות 139,000 בממ״ק. אילו מבין הממצאים הבאים יאששו אבחנה של CML?

א. תאים צעירים במשטח דם היקפי, מעל 15% בלסטים במח עצם, בדיקת PCR עם BCR ABL חיובי
ב. משטח היקפי עם סטייה שמאלה, באזופיליה, אאוזינופיליה. במח עצם יחס M: E 15: 1 ובדיקת PCR עם BCR ABL חיובי
ג. במשטח דם היקפי תאים בשלים, סטייה שמאלה, באזופיליה, אאוזינופיליה, בדיקת PCR עם BCR ABL חיובי מדם היקפי
ד. במשטח דם היקפי תאים צעירים עם BCR ABL שלילי, ו JAK2 חיובי

95. בן 53, מעשן 20 שנות קופסא, פונה למלר״ד לאור שיעול דמי מזה יומיים כאשר בשעתיים האחרונות נמדדה כמות של בערך כוס דם בשיעול. בבדיקתו סטורציה 87% באוויר חדר, מתוקנת עם 2 ליטר ל 98%, לחץ דם 90/60, דופק 110 לדקה, סדיר. לאחר ווידוא נתיב אוויר מוגן, מה הצעד הבא המומלץ ביותר לניהול המקרה?

א. אמבוליזציה של המערכת הברונכיאלית
ב. ברונכוסקופיה קשיחה בחדר ניתוח
ג. ניתוח כריתת הממצא המדמם
ד. Prone position

96. בת 68 מאובחנת עם ממאירות שד מזה חמש שנים. התקבלה בשל הדרדרות במצב ההכרה והתפקוד. בבדיקה היא לא מגיבה לסביבתה. במעבדה: קריאטינין 1.7 מ״ג/ד״ל , סידן 16 מ״ג/ד״ל, זרחן 1.2 מ״ג/ד״ל, אלבומין 3.4 ג/ד״ל, ALP תקין. מה הטיפול הנכון ביותר כעת?

א. normal Saline תוך ורידי - 2-3 ליטרים
ב. Hartman תוך ורידי - 2-3 ליטרים
ג. denosumab תוך ורידי במינון של 100 מ״ג
ד. pamidronate תוך-ורידי במינון 90 מ״ג

97. איזה מבין המשפטים הבאים נכון לגבי מתן נוזלים באי ספיקת כליות חדה?

א. קיימת התוויה חד משמעית למתן נוזלים
ב. תמיסת הבחירה בנוכחות בססת מטבולית היא רינגר לקטט
ג. יש להימנע ממתן סליין 0.9% בחולים עם חמצת מטבולית היפרכלורמית
ד. יש התווית נגד למתן תמיסות המכילות ביקרבונאט במקרה של רבדמיוליזה

98. בת 85 הופנתה להערכה בשל קוצר נשימה מזה מספר חודשים. בבדיקה: לחץ דם 180/90, דופק 65 לדקה, סטורציה 98% באוויר חדר. באקו לב מקטע פליטה 60%, שטח מסתם אאורטלי 0.7 סמ״ר, מפל לחצים ממוצע על פני המסתם 30 ממ״כ. מה יהיה הצעד הבא בניהול המקרה?

א. הפניה להחלפת המסתם האורטלי בצנתור
ב. הפניה לבדיקת אקו דובוטמין
ג. הפניה לבדיקת אקו חוזרת לאחר איזון מיטבי של לחץ הדם
ד. הפניה לבדיקת Cardiac MRI

99. נקרא/ת לייעוץ במחלקה הפסיכיאטרית בנוגע למטופל עם חשד לאנצפלופתיה. בבדיקת דם אמוניה מוגברת. איזה תכשיר סביר שנטל?

א. Clozapine
ב. Carbamazepine
ג. Valproic acid
ד. Risperidone

100. איזו תרופה (במינונים מקובלים) עלולה בסבירות הגבוהה ביותר לגרום לתמונה דמוית דליריום במבוגרים?

א. Amitriptyline
ב. Donepezil
ג. Memantine
ד. Rivastigmine

בהצלחה!